GLOBAL FINANCING FACILITY

SUPPORTED BY WORLD BANK GROUP

L'analyse de couverture dans FASTR

Comment la plateforme compte les personnes à servir, et ce que cela change, étape par étape

FASTR Useful Data

Première partie : le problème, avec un exemple

4 000 enfants vaccinés. Est-ce beaucoup ?



Centre de santé du district

4 000 enfants vaccinés cette année

Beaucoup ? Peu ? Impossible de le dire avec ce seul chiffre.



?

enfants dans le district

Pour répondre, il faut savoir combien d’enfants vivent dans le district.

D'où vient le chiffre qu'on utilise aujourd'hui

Il y a dix ans



Le recensement compte tout le monde

100 000 habitants

Chaque année depuis

+1 an	+2 ans	+3 ans	…
× 1,03	**× 1,03**	**× 1,03**	**× 1,03**
103 000	106 000	109 000	…

On fait grossir le chiffre du même pourcentage, partout

Puis on prend une part

4 % d’enfants
de moins d’un an

5 000

enfants « attendus »

C’est ce chiffre, la population cible, qui est inscrit dans DHIS2 et dans les plans.

Il suppose que tout le monde grandit au même rythme et que personne ne déménage.

Mais entre deux recensements, les gens bougent

District A · près de la mine





Des familles sont arrivées

8 000 enfants

la projection en attendait 5 000



déménagement

District B · zone rurale





Des familles sont parties

3 000 enfants

la projection en attendait 5 000

Résultat : des couvertures qui ne veulent rien dire

District A

4 000 enfants vaccinés

5 000 enfants « attendus »

80 %

Le vrai chiffre : 4 000 sur 8 000, soit 50 %

District B

3 300 enfants vaccinés

5 000 enfants « attendus »

110 %

Plus de vaccinés que d'enfants ? Le 5 000 est faux.

Les deux districts ont vacciné correctement. Ce sont les « 5 000 » qui sont faux.

Deuxième partie : comment FASTR compte

L'idée de FASTR : compter là où les gens passent

La plupart des femmes enceintes passent par le centre de santé



Centre de santé



8 femmes sur 10 viennent en consultation prénatale



2 ne viennent pas

Le centre de santé « voit » presque tout le monde. C’est là que FASTR va compter.

Ce que dit l'enquête : 8 femmes sur 10 viennent

L’enquête ménages demande à chaque femme : « êtes-vous allée en consultation prénatale ? »



8 ont répondu oui 2 ont répondu non

Sur 10 femmes enceintes, 8 viennent.

Ce chiffre vaut pour tout le pays et toutes les femmes, vues ou non. Une enquête tous les cinq ans.

Ce que dit DHIS2 : 8 000 femmes sont venues



Centre de santé

Registre DHIS2 · cette année

8 000

premières consultations prénatales

comptées une par une, chaque mois



Ce sont les « 8 sur 10 » : celles qui sont venues

DHIS2 compte les femmes vues. Il ne peut pas compter celles qui ne sont pas venues.

Donc elles étaient 10 000

Si 8 femmes vues vont avec 2 femmes non vues…



8 vues | 2 non vues

… alors 8 000 femmes vues vont avec 2 000 femmes non vues.

8 000
vues au centre de santé (DHIS2)

+

2 000
non vues

= 10 000 femmes enceintes dans le district

Les 2 000 non vues sont déduites des 8 000 vues. Personne ne les a comptées, et pourtant on les a.

La même idée, écrite en calcul

« 8 sur 10 »	8 000 ÷ 0,80	= 10 000
s’écrit 0,80	femmes vues ÷ part des femmes vues	toutes les femmes enceintes

Diviser par 0,80, c’est la même chose que multiplier par 10 et diviser par 8 :

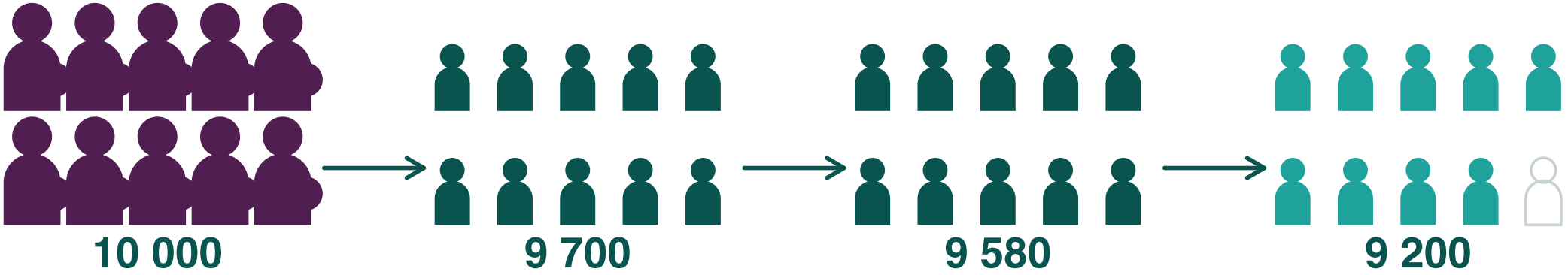
8 000 × 10 ÷ 8 = 10 000

Vous n’avez pas besoin de faire ce calcul. FASTR le fait pour chaque district et chaque année.

Des grossesses aux enfants à vacciner

Toutes les grossesses ne donnent pas un enfant à vacciner

La démographie dit combien on en perd à chaque étape. Ces taux sont ceux du pays.



Chaque pictogramme vaut 1 000 personnes. Le district a 9 200 enfants à vacciner, pas 5 000.

La couverture, enfin : 43 %, pas 80 %

Avec la projection du recensement

4 000 enfants vaccinés

5 000 enfants « attendus »

80 %

On croit que le district a presque fini.

Avec le comptage FASTR

4 000 enfants vaccinés

9 200 enfants qui sont vraiment là

43 %

Plus de la moitié des enfants restent à vacciner.

Mêmes 4 000 enfants vaccinés. La décision à prendre n’est pas du tout la même.

Deux règles pratiques pour l'étape 1

On garde la valeur de l'enquête jusqu'à la suivante. L'enquête de 2021 dit « 8 sur 10 ». Il n'y en a pas eu depuis. Pour 2022, 2023 et 2024, FASTR continue d'utiliser « 8 sur 10 », avec le nombre de consultations de chaque année. Quand une nouvelle enquête sort, elle remplace l'ancienne.

S'il y a deux enquêtes la même année, l'EDS passe avant la MICS.

Le même raisonnement marche avec d'autres services. Avec les accouchements en établissement et la part de femmes qui accouchent en établissement, on retrouve le nombre de naissances. Avec le premier vaccin Penta et sa couverture d'enquête, on retrouve le nombre de nourrissons.

Troisième partie : ce que la plateforme fait, dans l'ordre

Vue d'ensemble : deux modules, quatre étapes

MODULE « DÉNOMINATEURS DE COUVERTURE »

Étapes 1 à 3

1. Estimer une population de départ à partir d'un service et de la dernière enquête
2. En déduire les autres populations par la cascade démographique
3. Choisir, parmi les chaînes obtenues, celle qui colle le mieux aux projections de l'ONU

MODULE « ESTIMATIONS DE COUVERTURE »

Étape 4

4. Diviser chaque volume de service par son dénominateur, puis prolonger la dernière enquête avec la tendance du SNIS

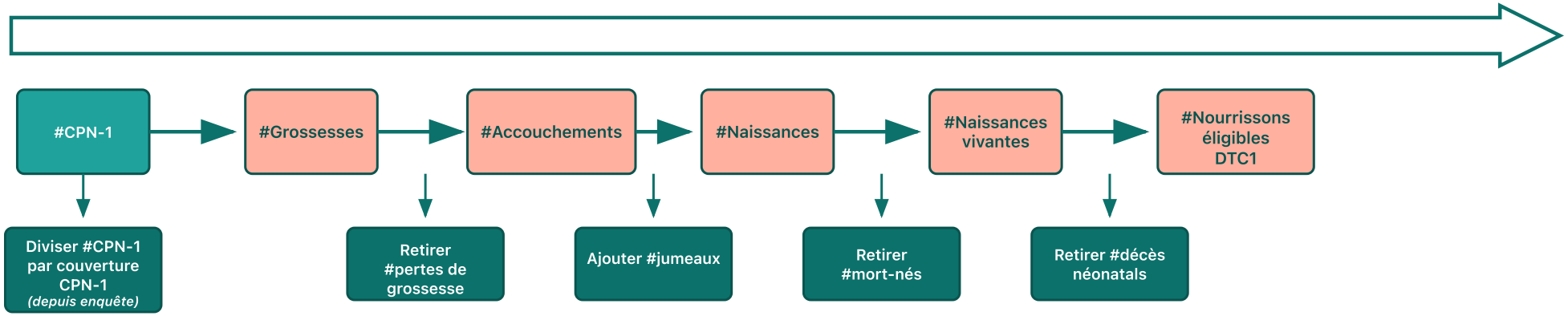
ENTRÉES

Trois sources

- Les volumes du SNIS, **après correction de la qualité**
- Les enquêtes EDS et MICS, fournies avec la plateforme
- Les projections de population de l'ONU (UN WPP)

Étape 2, en détail : la cascade et ses formules

C'est le même chemin que la page précédente, avec les formules que FASTR applique à chaque étape.



Valeurs par défaut	Taux perte grossesse = 0,03	Taux jumeaux = 0,015	Taux mortinatalité = 0,02	TMN = 0,03	TMPN=0,02

Les cinq taux de la cascade

Valeurs par défaut

Taux	Défaut
Perte de grossesse	3 %
Jumeaux	1,5 %
Mortinatalité	20 ‰
Mortalité néonatale	39 ‰
Mortalité postnéonatale	28 ‰

Ce qu'il faut en savoir

- Ce sont des valeurs de départ, pas des valeurs du pays. Elles se remplacent par l'EDS ou les estimations UN IGME dans **Résultats → Paramètres par défaut des modules**.
- Un taux changé s'applique à chaque paquet de résultats généré ensuite.
- Au niveau des régions et des districts, ce sont ces taux nationaux qui s'appliquent.

Quatre points de départ, donc quatre chaînes

Les points de départ

Service	Population estimée d'abord
CPN1	Grossesses
Accouchements	Naissances vivantes
BCG	Naissances vivantes
Penta1	Nourrissons après la période néonatale

Pourquoi plusieurs

- La cascade se parcourt dans les deux sens : depuis Penta1, on remonte aux naissances vivantes, puis aux grossesses.
- Chaque point de départ donne donc une estimation complète et indépendante de toutes les populations.
- Quatre chaînes, c'est quatre réponses à la même question. L'étape suivante en retient une.

Étape 3 : retenir la chaîne la plus crédible

Au niveau national, chaque chaîne est comparée aux projections de l'ONU pour trois populations : grossesses, naissances vivantes, nourrissons éligibles au Penta. Pour chaque chaîne, on calcule le rapport chaîne ÷ ONU, année par année, et on prend la médiane.

La chaîne dont la médiane est la plus proche de 1 est retenue. Une médiane de 1,15 signifie que la chaîne compte 15 % de personnes de plus que l'ONU.

La chaîne BCG ne participe pas à ce choix automatique, car elle n'existe qu'au niveau national. Elle reste disponible en choix manuel.

Une seule chaîne est retenue, puis appliquée à tous les indicateurs et à tous les niveaux géographiques, pour que les couvertures restent comparables entre eux.

Étape 4a : calculer la couverture

Pour chaque indicateur, chaque année et chaque niveau géographique :

couverture = volume de service du SNIS ÷ dénominateur de la chaîne retenue.

Le volume utilisé est celui **corrigé des valeurs aberrantes** par le module d'ajustement, le réglage par défaut. Un indicateur qui n'a aucun volume n'a pas de couverture, plutôt qu'un zéro trompeur.

La couverture n'est pas plafonnée. Une valeur au-dessus de 100 % est un signal : le dénominateur est trop petit, ou le numérateur compte des personnes venues d'ailleurs.

Étape 4b : prolonger la dernière enquête

L'enquête reste la mesure de référence. FASTR part de sa dernière valeur et la fait évoluer comme la couverture SNIS, d'une année à l'autre.

Exemple. Enquête 2021 : 82 %. Couverture SNIS : 80 % en 2021, 83 % en 2022, 85 % en 2023.

Le SNIS gagne 3 points puis 2 points. La projection donne 85 % en 2022 et 87 % en 2023.

Le niveau vient de l'enquête, la tendance du SNIS.

Année	SNIS	Enquête	Projection
2021	80 %	82 %	82 %
2022	83 %		85 %
2023	85 %		87 %

Lire un graphique de couverture

Trois séries sur le même graphique

- **Couverture SNIS** : volumes corrigés ÷ dénominateur, chaque année
- **Points d'enquête** : les valeurs EDS ou MICS, les années où il y en a
- **Projection** : la dernière enquête prolongée par la tendance du SNIS

Laquelle regarder

- Pour la **tendance** : la couverture SNIS, disponible chaque année et par district
- Pour le **niveau** : la projection, calée sur l'enquête
- Si les deux s'écartent fortement, c'est le dénominateur qu'il faut questionner avant les services

> ***Par district, seule la couverture SNIS existe. Les enquêtes ne descendent pas à ce niveau.***

Dans la plateforme, dans l'ordre

1 · RÉGLER

Paramètres par défaut des modules

Menu **Résultats**. Carte **Dénominateurs de couverture** : les cinq taux et le niveau de calcul (national, région, district). Carte **Estimations de couverture** : la chaîne, « auto » par défaut.

2 · GÉNÉRER

Un paquet de résultats

Générer un nouveau paquet avec les deux modules de couverture cochés. L'ajustement de la qualité doit être inclus : il fournit les volumes corrigés.

3 · LIRE

Les visualisations

Séries temporelles de couverture, national puis par région et par district, avec les points d'enquête. **Couverture (SNIS uniquement)** pour un tableau de bord opérationnel.

Avant de faire confiance au résultat

Vérifier

- La **dernière enquête** disponible pour le pays est bien celle utilisée
- Les **cinq taux** sont ceux du pays, pas les défauts
- La **chaîne retenue** et sa médiane, dans le journal de génération

Interpréter avec prudence

- Une couverture **au-dessus de 100 %** : dénominateur à revoir
- Un **petit district** : quelques établissements suffisent à faire bouger la courbe
- Un **changement brusque** la même année dans tous les indicateurs : souvent un problème de rapportage, pas de service

En une page

1. Un service mesuré par l'enquête donne une population de départ : volume SNIS ÷ couverture d'enquête.
2. La cascade démographique en déduit les autres populations avec cinq taux.
3. Quatre chaînes sont construites ; celle qui colle le mieux aux projections de l'ONU est retenue pour tout.
4. La couverture est le volume corrigé divisé par ce dénominateur ; la dernière enquête est prolongée par la tendance du SNIS.

Le résultat se lit chaque année et par district, là où les enquêtes ne vont pas.

FASTR

Du volume de service à la couverture, chaque année et par district